

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

CUESTIONARIO DE AGRESIÓN DE BUSS & PERRY (AQ)

Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo • Evaluación Multidimensional de la Conducta Agresiva, Ira y Hostilidad

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Cuestionario de Agresión (AQ).
Nombre Original (Inglés)	<i>The Aggression Questionnaire (AQ)</i>
Autores del Diseño Original	Drs. Arnold H. Buss y Mark Perry (1992), <i>University of Texas at Austin</i> , EE. UU.
Adaptación al Español	Drs. José Manuel Andreu, M. Elena Peña y José Luis Graña (2002), Universidad Complutense de Madrid.
Eje Clínico y Clasificación	Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo. Evaluación de agresividad física/verbal, desregulación de ira y sesgos hostiles.
Tipo de Instrumento	Cuestionario de autoinforme estandarizado de 29 ítems con escala Likert de 5 puntos (1 a 5).
Población Diana y Rango	Adolescentes y adultos (12 a 75 años). Aplicable en clínica ambulatoria, hospitales, peritaje forense y laboral.
Tiempo de Administración	8 a 12 minutos en autoadministración guiada o lectura asistida.
Régimen de Licencia	Dominio público científico para investigación académica, práctica clínica y pericial sin fines comerciales directos.

2. MARCO TEÓRICO: EL MODELO JERÁRQUICO MULTICOMPONENTE DE BUSS Y PERRY

El cuestionario AQ de Buss y Perry (1992) representa la evolución psicométrica madura del clásico inventario BDHI (Buss-Durkee Hostility Inventory, 1957). El modelo postula que la conducta violenta y agresiva no responde a un rasgo unitario monolítico, sino a un **sistema jerárquico integrado por tres niveles interconectados**:

- Nivel Instrumental / Motor (Conductual):** Agresividad Física y Agresividad Verbal. Representa las acciones directas observables destinadas a infligir daño corporal, intimidación, deterioro de objetos materiales o agresiones verbales abiertas en conflictos interpersonales.
- Nivel Emocional / Fisiológico (Afectivo):** Ira. Implica la hiperactivación del sistema nervioso autónomo simpático, vivencias subjetivas de enojo, irritabilidad explosiva e incapacidad de modulación emocional. Constituye el puente dinámico entre el estímulo y la descarga motora.
- Nivel Cognitivo / Esquemas Atribucionales:** Hostilidad. Involucra distorsiones cognitivas estables, suspicacia persecutoria, desconfianza hacia los motivos ajenos, rencor crónico, envidia y sesgo de atribución hostil.

3. COMPOSICIÓN FACTORIAL DE LAS 4 SUBESCALAS (29 ÍTEMS)

Subescala	N.º Ítems	Rango Dir.	Contenido Clínico e Ítems Constituyentes
1. Agresividad Física	9 ítems	9 a 45	Violencia corporal, peleas, uso de fuerza física y rotura de objetos. Ítems: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 24 (inv), 27 y 29 .
2. Agresividad Verbal	5 ítems	5 a 25	Discusiones acaloradas, desacuerdos abiertos e insultos a otros. Ítems: 2, 6, 10, 14 y 18 .
3. Ira	7 ítems	7 a 35	Activación psicofisiológica, impaciencia, pérdida de control del genio. Ítems: 3, 7, 11, 15 (inv), 19, 22 y 25 .
4. Hostilidad	8 ítems	8 a 40	Resentimiento, suspicacia, envidia y atribución de malicia a los demás. Ítems: 4, 8, 12, 16, 20, 23, 26 y 28 .
TOTAL AQ	29 ítems	29 a 145	Índice global de agresividad acumulada. Suma directa de las 4 subescalas tras invertir ítems 15 y 24.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. EVIDENCIA DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD PSICOMÉTRICA

Estructura Factorial	El Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) corrobora la estructura tetrafactorial (Agresividad Física, Agresividad Verbal, Ira y Hostilidad) tanto en muestras comunitarias como forenses españolas (Andreu et al., 2002; Santisteban et al., 2007; CFI = 0.93, RMSEA = 0.052).
Consistencia Interna (Alfa)	Confiabilidad excelente y robusta: Agresividad Física (alfa = 0.86), Ira (alfa = 0.77), Hostilidad (alfa = 0.72), Agresividad Verbal (alfa = 0.68) y Puntuación Total AQ (alfa = 0.88).
Validez Concurrente	Correlaciones positivas elevadas con escalas de expresión de ira (STAXI-2, $r = 0.65$ a 0.78), impulsividad motora (BIS-11, $r = 0.58$) y escalas de psicopatía primaria y secundaria de Levenson (LSRP, $r = 0.62$).
Validez Discriminante	Diferencia con gran significación estadística ($p < 0.001$) entre sujetos de población general y delinquentes violentos internados en centros penitenciarios, especialmente en las dimensiones de Agresividad Física e Ira.

5. ALGORITMO Y PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN

El evaluado califica cada una de las 29 afirmaciones en una escala ordinal de 1 a 5:

- 1 = Completamente falso para mí • 2 = Bastante falso para mí • 3 = Ni verdadero ni falso • 4 = Bastante verdadero • 5 = Completamente verdadero.

REGLA CRÍTICA DE INVERSIÓN PREVIA (PASO 1 OBLIGATORIO):

Antes de realizar sumatorios parciales o totales, es imprescindible invertir la escala de los dos ítems redactados en sentido positivo: • **Ítem 15:** “Soy una persona apacible” → (1 = 5, 2 = 4, 3 = 3, 4 = 2, 5 = 1). • **Ítem 24:** “No encuentro ninguna buena razón para pegar a una persona” → (1 = 5, 2 = 4, 3 = 3, 4 = 2, 5 = 1).

6. BAREMOS NORMATIVOS Y ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO (ADULTOS)

Nivel Clínico	Media Varones	Media Mujeres	Centil (Pc)	Significación Clínica y Pronóstico Conductual
1. Normativo	< 72	< 68	< Pc 70	Adecuado control inhibitorio motor, estabilidad del afecto y baja hostilidad cognitiva.
2. Medio-Alto	72 a 82	68 a 78	Pc 70 - 84	Irritabilidad reactiva en situaciones de estrés o conflicto. Agresividad verbal predominante.
3. Riesgo Elevado	83 a 94	79 a 90	Pc 85 - 94	Dificultades notorias de convivencia, descontrol de impulsos y suspicacia interpersonal acusada.
4. Severo Forense	>= 95	>= 91	>= Pc 95	Riesgo crítico de agresión física, violencia reactiva/instrumental o problemas legales recurrentes.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE INTERVENCIÓN MODULAR SEGÚN EL PERFIL DEL AQ

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y TRATAMIENTO SEGÚN FACTOR PREDOMINANTE:

1. **Perfil Ira Dominante (Ira ≥ 23):** Intervención fisiológica y emocional prioritaria. Técnicas de relajación muscular progresiva, respiración diafragmática, biofeedback y protocolo de tiempo fuera (Time-Out) ante picos de excitación simpática.
2. **Perfil Hostilidad Dominante (Hostilidad ≥ 25):** Intervención cognitiva. Terapia de reestructuración para desarticular sesgos atribucionales hostiles, lectura de intenciones ajenas e interpretación catastrofista de interacciones sociales.
3. **Perfil Agresión Física Dominante (AF ≥ 25):** Intervención conductual y control de contingencias. Entrenamiento en solución estructurada de problemas, detección de señales tempranas de agitación y reorientación no violenta de impulsos.
4. **Perfil Agresión Verbal Dominante (AV ≥ 18):** Entrenamiento intensivo en asertividad y habilidades de comunicación no violenta.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: EVALUACIÓN EN CONFLICTO LABORAL GRAVE

Paciente: Varón de 34 años, jefe de equipo en empresa logística, derivado por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales tras un episodio de confrontación violenta en el trabajo donde propinó un empujón a un subordinado y rompió un teclado tras un error operativo. **Puntuaciones AQ:** Puntuación Total = **96** (Centil 96, Rango Severo). • **Agresividad Física: 29** (Centil 94; ítems 1, 5 y 29 puntuados con 4 y 5). • **Ira: 28** (Centil 96; elevación crítica en falta de control de genio y activación somática). • **Agresividad Verbal: 19** (Centil 88; discusiones acaloradas y gritos frecuentes). • **Hostilidad: 20** (Centil 65; nivel normativo-medio; no presenta paranoia estructurada ni rencor persecutorio basal). **Juicio Diagnóstico y Plan Terapéutico:** Patrón de agresividad impulsivo-reactiva con grave desregulación afectiva (hiperreactividad de ira) y déficit de autocontrol inhibitorio motor, en ausencia de hostilidad o psicopatía primaria. Se implementa programa TCC ambulatorio de 12 sesiones: desescalada fisiológica rápida, técnica de resolución de problemas bajo estrés y reestructuración de distorsiones de exigencia ("las cosas tienen que salir perfectas"). A los 4 meses, su AQ Total desciende a 68 (Pc 55), sin nuevos incidentes conductuales.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD, LIMITACIONES FORENSES Y DEBER DE PROTECCIÓN

DEBER DE ADVERTENCIA Y SEGURIDAD:

Si durante la entrevista o en el ítem 27 se constatan amenazas creíbles y específicas de muerte o lesiones contra terceros identificables, rige la excepción deontológica del deber de protección y comunicación a autoridades.

CONTROL DE DESEABILIDAD SOCIAL:

En contextos forenses, de custodia o selección laboral, los pacientes pueden disimular su agresividad. Es indispensable triangular los hallazgos del AQ con entrevistas a colaterales e historiales de conducta.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Buss, A. H., & Perry, M. (1992). The Aggression Questionnaire. *Journal of Personality and Social Psychology*, 63(3), 452–459.
2. Andreu, J. M., Peña, M. E., & Graña, J. L. (2002). Adaptación psicométrica de la versión española del Cuestionario de Agresión. *Psicothema*, 14(2), 476–482.
3. Santisteban, C., Alvarado, J. M., & Recio, P. (2007). Evaluation of a Spanish version of the Aggression Questionnaire: A study on adolescents and adults. *The Spanish Journal of Psychology*, 10(1), 147–160.
4. Morales-Vives, F., Camps, E., & Lorenzo-Seva, U. (2020). Development and validation of the Short-Form of the Aggression Questionnaire (AQ-12). *Journal of Affective Disorders*, 274, 532–537.